

1869

REPARTO 17

Suffolter 8-12-14

Il giorno 12 novembre alle ore 17,30 il gruppo composto da Sturani, Tronzano e Nasi, visita il reparto 17. Attualmente questo reparto, che è di accettazione e smistamento, ospita 29 degenti, vi sono 22 infermieri e 3 Medici: Desana, Gasca, Villata.

I degenti, quando entrano in ospedale vengono portati tutti in questo reparto dove rimangono in osservazione, qualche ora, qualche giorno o, al massimo, un mese; trascorso questo periodo e formulata la diagnosi, o vengono dimessi o vengono avviati verso altri reparti.

Il reparto è predisposto per ospitare 63 malati, ma in periodi di punta ve ne sono stati persino 78; si ricorre allora ad un locale del secondo piano dove i malati sono posti a dormire. Normalmente al piano terreno c'è un dormitorio con 19 letti dove vengono tenuti i malati che stanno a letto anche di giorno o quelli che, più agitati, hanno bisogno di maggiore sorveglianza. Al piano terreno c'è anche una sala di soggiorno con parecchi tavoli dove i degenti mangiano. Da pochi mesi è stata concessa loro la forchetta, ma non è stato ancora concesso il coltello. Quando i degenti sono molto numerosi, vengono messi dei tavoli anche nel corridoio. Per quanto i locali siano stati ripuliti di recente, l'impressione è di grande squallore e desolazione. Parrebbe necessario che il primo incontro tra il malato e luogo di cura avvenisse in locali più accoglienti. Quando noi entriamo, attraversiamo il dormitorio del piano terreno: in un letto sta dormendo profondamente un malato entrato da poco. Il suo sonno profondo è probabilmente dovuto ai farmaci somministratigli per calmarlo. Chiediamo se ve ne sono di contenuti. Risulta di no, nemmeno nelle stanzette singole al primo piano dove dovrebbero essere ospitati i malati più agitati. Da quanto dice un infermiere parrebbe che, al contrario, attualmente in quelle stanzette dormano i malati meno gravi. A questi malati-quasi-sani è pure concesso di star fuori quasi tutto il giorno. In questo reparto vengono ospitati per breve tempo anche malati che furono già altre volte in ospedale psichiatrico e la cui diagnosi è quindi già chiara.

I malati, quando noi entriamo, stanno nel soggiorno del piano terreno e nel corridoio. Alcuni indossano ancora panni borghesi; dipende dal capo-infermiere fare loro tale concessione se lo richiedono. Altri invece indossano divise: pantaloni e blusotto di pesante stoffa grigio-ferro. Molte divise appaiono nuove, di foggia e di colore gradevole, tanto da non dare nell'occhio in nessun modo. Molti degenti sono giovani, quasi tutti colpiscono per la tristissima espressione del viso e degli occhi. Uno solo è profondamente irrequieto o è insistente e molesto; gli infermieri mostrano con lui pazienza.

Alcuni malati, tra quelli che avevano un discorso coerente, interrogati,

dicono di non essere mai stati maltrattati dagli infermieri né di aver visto maltrattare alcuno. Solamente il malato piccoletto e molesto, dice di esser stato picchiato in testa e fa sentire una bozza ~~che però non si sente~~. Pare che a picchiare siano due malati-lavoratori che si recano in questo reparto per aiutare a rigovernare. La cosa non è però accertata.

Il medico di turno, dott. Calzi, richiesto perché i malati in stato di furia vengano portati all'ospedale legati e imbavagliati, anziché tranquillizzati con un'iniezione, specifica che, in certe condizioni, iniezioni anche potentissime sono del tutto inefficaci e che non si potrebbe ricorrere ad altri farmaci poiché potrebbero essere letali e che quindi, in determinate condizioni, il rimedio meno grave è ancora quello di immobilizzare il malato. Questi vengono portati all'ospedale dalla Croce Verde: l'ambulanza giunge fino alla soglia del reparto e qui il malato viene preso in custodia dagli infermieri del reparto. Questi però lamentano che quando giunge di notte un ~~malato~~ malato in stato di grave agitazione, essi, che di notte al pian terreno sono solo in due, devono abbandonare la sorveglianza degli altri malati per occuparsi del nuovo arrivato. Normalmente di notte due infermieri stanno al pian terreno e uno al primo piano.

Il gruppo sale al primo piano accompagnato anche dal prof. Gamna, che è venuto a fare un giro nel reparto. Qui si sta allestendo un secondo soggiorno più piccolo, ma che sarà dotato di un ping-pong, di bigliardini ecc. Vi sono alcune camerette singole, tutte vuote, e un dormitorio più grande: tutto appare pulito e in ordine: i servizi igienici sono 4 al primo piano e 3 al pian terreno. I lavandini sono 10 in tutto. C'è anche una doccia e un bagno. Anche qui, come negli altri reparti, i malati non dispongono di nessun mobile per tenere gli effetti personali che vengono custoditi dall'infermiere capo il quale custodisce, amministra e distribuisce anche il danaro dei singoli degenti. Tiene annotato, in un quaderno che ci fa vedere, giorno per giorno, le spese che ogni degente fa. Anche qui tra i degenti c'è chi fuma e chi, non disponendo nemmeno di una lira, guarda gli altri fumare in attesa

che un compagno o un infermiere, impietosito, gli regami una sigaretta.

Alcuni malati si mostrano molto ansiosi di telefonare a casa per dare o per avere notizie. Quelli che si trovano nel reparto da più di quindici giorni si mostrano molto depressi e temono di non essere dimessi. Uno dice che, una volta uscito, farà qualsiasi lavoro pur di non tornare mai più lì dentro. E un maestro, figlio di meridionali, che però non riuscì a far scuola e lavorava come manovale. Dice che ebbe una crisi di nervi provocata da vicini rumorosi i quali telefonarono alla Croce Verde e lo fecero internare. Pare che la madre sia una donna debole sopraffatta dalla vita. Si esprime in modo lucido e coerente. Un altro è un operaio di Pinerolo, padre di tre bambini. Dice che ha un buon lavoro e che guadagna bene, ma

La moglie non si occupava di nulla , lui tornava a casa e doveva ancora
e da mangiare per sé e per i figli : i nervi non ressero ✖

Molti malati si stringono attorno a noi raccontando i loro casi ; alcuni
i dicono i loro nomi , vorrebbero che ci si occupasse di loro , ci dicono
di telefonare alle famiglie cheli vadano a trovare . Colpisce l'espressione
di intenso e cupo dolore di certi volte , specie dei più giovani .

Lamentano che i medici non li " visitano" , però poi ammettono di aver
avuto con i medici dei " colloqui" .Ciò che più colpisce è l'assoluta inat-
tività dei malati , anche di quelli chepotrebbero trascorrere il tempo
con qualche occupazione .Gli infermieri dicono che possono giocare a
carte, leggere, giocare a dama .

Dai discorsi , gli infermieri appaiono dotati di buon senso e di
buona volontà , non conoscono però nessuna diagnosi e tuttavia decidono
loro chi debba esser visitato dal medico ; l'infermiere capo dice però
che lui mette in nota giorno per giorno i malati che vogliono conferire
con il medico .Il responsabile è il dott.Villata .

Per il gruppo

Luisa Storace

Prof. Dott. LUCA TRONZANO
PROFESSORE DOCENTE DI MEDICINA LEGALE E
NELLE ASSICURAZIONI NELL' UNIVERSITA

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 46 - TEL. 593.065
10129 - TORINO

- osservazioni sul sopralluogo di mercoledì 12 Novembre 1969
(ore 16.30-18.30) al Reparto Osservazione *18*
- si tratta solo di brevi note da aggiungere alla relazione Sturani
che compendia gli appunti dettati collettivamente (Sturani-Nasi-
Tronzano) subito dopo il sopralluogo
- un degente che non ricordo mi segnalò che un infermiere che picchia
i degenti è il marito di una certa non meglio identificata MARIUCCIA,
pur essa dipendente dell'Ospedale ed in servizio allo spaccio
- ho constatato che, per la distribuzione del pasto serale, gli infermieri
erano coadiuvati da un ricoverato il quale dava chiari segni di aggres-
sività : ci mancò poco che venisse alle mani con un ricoverato che mi
aveva segnalato essere egli uno di quelli che picchiano (evidentemente
era stato scambiato per un infermiere)

Il giorno 29 dicembre alle ore 9 Fonzi , Frugiuele , Sturani
si recano al reparto 17 per reperire alcuni dati .

Parlano con l'infermiere ~~padre~~ sig. Gallino e con il dott. Villata .
In quel reparto , accettazione , il numero dei degenti varia fino a un
massimo di 63 . In quel giorno i degenti erano 35 con 24 infermieri .
Alle ore 9 erano di turno 6 infermieri + il sottocapo . Di notte
sono tre come negli altri reparti . Nella visita precedente il sottocapo
aveva fatto osservare che 3 infermieri erano pochi in un reparto dove
di notte può essere portato un uomo in furia per il quale bastano a mala
pena due infermieri .

In questo reparto entrano in media 75-80 malati al mese . Il
30% sono alcolisti , questi , tosto diagnosticati , vengono subito avviati
al reparto 18 . *sono in forte aumento anche fra i meridionali . Nell'ultimo anno sono entrati*
Una volta gli alcolisti , tra i meridionali , erano
pochissimi , ora , dice il medico , anche i meridionali han preso
l'abitudine di bere . Aggiunge però anche che non sempre è la quantità
del vino bevuto che conta, ma la cattiva sopportazione del medesimo ; questo
è dovuto a fattori vari ; alcuni bambini bevono fin da piccoli poiché le
famiglie ignoranti pensano che " il vino rinforza " , questi bambini
sono predestinati ~~ad-esse~~ a diventare degli alcolisti . Dice il dott.
Villata che l'alcolismo è una malattia sociale *(per tutti sono opio e comfort)* e che come tale dovrebbe
essere combattuta con un'adeguata propaganda ed educazione di tutta la
popolazione . *Pochissimi sono i drogati , quasi tutti medici e farmacisti*
Ci dà poi uno specchietto dal quale risultano i malati entrati
nell'ultimo ~~mese-e-la-lore-dimissione~~ anno

genna	entrati	sett.	centr.	merid.	alcolisti
gennaio	69	38	6	25	19
febbraio	64	30	6	28	15
marzo	61	38	6	16	24
aprile	55	20	4	10	17
maggio	71	44	6	23	20
giugno	73	39	4	28	14
luglio	99	54	4	40	22
agosto	79	52	4 12	40	26
settembre	78	36	12	30	22
ottobre	86	44	6	36	19
novembre	80	14	2	15	22
dicembre	non si hanno ancora i dati				

In questo reparto i malati godono di un confort maggiore che negli altri reparti , si sta allestendo al piano superiore una saletta di ~~riera~~ giochi , giocano particolarmente a carte ; pare che il ping pong sia stato sfasciato .Possono ricevere visite , ~~pare però che in genere non siano frequenti~~ . (Il sig.Gilardi , che lavora a Collegno come volontario e ne studia i problemi da più di un anno ha fatto ^{a questo proposito} un'osservazione molto interessante : le visite sono tanto più frequenti quanto maggior garanzia la famiglia ha che il malato non sia dimesso .Ora che le dimissioni avvengono con più facilità , le visite sono diminuite , anche il fatto che i malati siano qualche volta accompagnati a visitare la famiglia , ha fatto sì che questa venga meno . Anche la notizia che la provincia dà alle famiglie che si riprendono un malato 40.000 mensili fino a un massimo di 18 mesi , ha fatto sì che le visite siano diradate) .

Il dott. Villata ritiene che la percentuale dei malati che potrebbero essere curati fuori dell'ospedale sia del 25% .Dice che tra i meridionali c'è più ~~cl~~amorosità , legata al loro temperamento , ma che i tipi di malattia sono gli stessi .Dice che nel reparto collaborano 8 volontari, 6 dei quali sono studenti ; il compito di queste persone è di tenere i contatti con le famiglie in modo da studiare se il malato , eventualmente dimesso possa tornare in un ambiente favorevole o meno . Richiesto se per la diagnosi vengano usati anche dei test , il dott.Villata dice di no, che è sufficiente un colloquio per stabilire di che tipo di malattia si tratti e che molto servono anche le relazioni quotidiane degli infermieri.

L'incontro tra malati ed ospedale è in genere drammatico , si scaricano contro la famiglia , i vicini , le autorità .

Dice che la necessità più sentita per questo reparto sarebbe un gran numero di camere ad un letto per evitare che ~~tutti i~~ ^{malati} vengano disturbati e non possano quindi riposare come dovrebbero .

Luisa Sturani Monti